

从肝论治咳嗽变异性哮喘的思路与方法

祝广钦 宁夏 胡孙林 孙霄 孙一珂 张海蓉 王若冲 张亚鹏 马淑然

【摘要】 “风袭于外,肝必内应”,咳嗽变异性哮喘病因以“风”为主,是一个由咳嗽逐渐发展为哮喘的动态阶段,其病程与病机展现出“由外及内,日久则伏”的特点。中医学将以“风”为因的疾病责于肝之失常,本文基于此进行从肝论治咳嗽变异性哮喘的探索,并根据咳嗽变异性哮喘的分期与病证的标本,以“祛外风—煦肝风—搜伏风”为基本方法,从理论基础、病机阐释与临床应用等方面分别论述了从肝论治咳嗽变异性哮喘的理论依据与临床价值。疾病初起,拟“祛外风”为首则,以防肺风扰肝;至中期须用“煦肝风”法治本,以平肝气之乱;久病入络,则以“搜伏风”为要,防肝风之受引复动;三法相辅相成,分期分层次地应用,共奏良功。

【关键词】 咳嗽变异性哮喘; 从肝论治; 肝风; 临床经验

【中图分类号】 R249 **【文献标识码】** A doi:10.3969/j.issn.1674-1749.2024.03.023

1970 年,Stanescu 和 Teculescu 声称其认识到了一种特殊类型的,症状仅有咳嗽而无喘息的哮喘。1972 年,Gluser 将这种特殊的哮喘命名为“变异型哮喘”^[1]。时至今日,现代医学已将此类疾病从咳嗽与哮喘中分离出来,单独命名为咳嗽变异性哮喘(cough-variant asthma,CVA)。本病患者众多,且具备一定的“咳—喘”转化性,因而已成为一个新兴的疾病研究热点^[2]。

CVA 的病因病机,以及其临床的症状表现都具有以“风”为主的特点^[3],因此医家们多将 CVA 归为“风咳”^[4]。既为咳,病机当在肺气失宣;而《素问·至真要大论篇》“诸风掉眩,皆属于肝”之论,又将其责于肝之失常。《杂病广要》言:“人之为风,有外之风,亦有内生之风……故无论贼风邪气从外来者,必先有肝风为之内因。”故本病主位在肝肺,是为“风袭于外,肝必内应”的病理逻辑。然而,目前中医学界对 CVA 进行的临床探索中,从肺论治者众,从肝探讨者寡,从肝论治的实践与研究值得探索。

1 风袭于外,肝风内动,日久风伏

自古以来,中医界多认为咳嗽之病因与风、痰、瘀有关,而其中尤以风为首,由此医家们多将 CVA 归为“风咳”^[4];现代医学的相关研究中,普遍将 CVA 归类为气道高反应性

疾病,其病程存在慢性气道炎症、支气管充血水肿及炎症细胞浸润^[5],认为其典型症状即咳嗽的发生,直接原因在于支气管平滑肌的强直、痉挛之状态^[6],恰属于中医学“风”的病理范畴。

学界关于 CVA 发病机制的探讨很多,如晁恩祥^[4]认为 CVA 挛急性咳嗽的发作是由于风邪伏肺;刘圣康等^[7]认为,CVA 病属风疾,将其风之动归因于虚,认识到了内风生成之因与内外风之间的关系;杜渊等^[8]以“风、痰、瘀”为小儿 CVA 的核心病机,分急性期、中期、缓解期论治,探讨了“风邪再生”的机制;李彦军等^[9]提出五脏伏风是 CVA 发病关键,一定程度上认识到了外风、肝风与伏风对于本病的影响。

笔者团队在此基础上认识并提出,CVA 的病程是一个由咳嗽逐渐发展为哮喘的动态阶段,其中“风”的病机展现出“由外及内,日久则伏”的特点,可分“风袭于外”“肝风内动”与“日久风伏”三个随疾病进展而彼此叠加的阶段性病机,治宜分阶段运用或联用“祛外风—煦内风—搜伏风”之法。

1.1 风袭于外,同气相召,肝风欲动

程钟龄《医学心悟》言“肺体属金譬若钟然,钟非叩不鸣……自外击之则鸣……自内攻之则亦鸣”,提示外风和内风是致咳的两大关键病因。武维屏“外风始受于肺,内风始于肝”之论^[10],为从肝、肺论治 CVA 提供了思路。

外风犯肺,肺气失宣发为咳嗽的机制,学界探讨者甚,此风咳初起之征兆也。而《素问·咳论篇》言“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”,提示外风在直袭于肺以外,对其余脏腑仍存在某种致咳的影响。以侯岁明^[11]为代表的学者肯定了这一观点,并认为外风致咳亦责于肝气之应:“风袭于外,肝必内应,风气相招也。”

可见,外风致咳非独犯肺,亦能扰肝,内外风气相召,而在体内形成肝风欲动的整体环境。若仅注意肺气的受邪与失宣,忽略肝肺互相引动的风气之扰,或解一时之急,而肝风

作者单位:102488 北京中医药大学中医学院[祝广钦(硕士研究生)、胡孙林(本科生)、孙霄(硕士研究生)、孙一珂(博士研究生)、张海蓉(博士研究生)、王若冲(博士研究生)、张亚鹏(博士研究生)、马淑然];北京中医医院肝病科[宁夏(硕士研究生)]

作者简介:祝广钦(1998-),2022 级在读硕士研究生。研究方向:天人相应理论与系统中医。E-mail:tongtongxing@126.com

通信作者:马淑然(1964-),博士,教授,博士生导师。研究方向:天人相应理论与临床实验研究。E-mail:mashuran64@sina.com

欲动的环境已成,如若再逢外风之扰,必当反复。

1.2 肝阴亏虚,挟风内刑,木击金鸣

CVA 进展一段时间后,肝风频频受扰,“欲动”终成“已动”。此时表现出的咳嗽症状不再是普通的肺气上逆,而是刺激性的、难以平息的气道痉挛;为外风所引动的肝风上扰气道,发为肝风性的气道痉挛与喘嗽。李冠仙《知医必辨》^[12]言“上而侮肺,肺属金,原以制肝木,而肝气太旺,不受金制,反来侮金,致肺之清肃不行,而呛咳不已,所谓木击金鸣也”,大抵如是。

叶天士^[13]言“内风乃身中阳气之变动”,可见内风本为生理之风,是阳气在体内运转而成的温煦之风;其既生于肝,本意便为柔化肝之刚强。其之所以挟相火化肝风、失温煦而动乱,盖因肝阴血之不足。如《本草经解》言:“肝血虚,则木枯火炎,乘以不胜,病咳逆上气矣。”受外风之扰动,肝气郁而难畅,壅为肝火,内风柔煦不及,则被肝火裹挟,共化为病理之肝风,进一步造成肝风内动的环境;此时肝风上袭肺位,使肺失肃降、气机紊乱,反应于气道则发为咳喘,此“木火刑金”之理也。如《临证指南医案》之言:“肝风妄动,旋扰不息,致呛无平期。”

肝风内动致风盛挛急有两大成因:一是外风干扰太强,引动内风;二是肝虚阴不制阳,阳欲化风。当人体进入肝风内动之环境后,肝气必乱而过旺,此时肺金难制肝木,肝亢直逆于肺,则击金而鸣,故见“呛无平期”。

1.3 风扰日久,伏风入络,引则复动

CVA 经年不愈,进展到后期,始向经典哮喘恶化。此时其咳象已发作剧烈,一遇风便反复。此时肝阴血亏虚已甚,经络空虚,如叶天士“久病入络”之说,风邪既有伏处,与痰、瘀交错,更难祛除。外风复扰,肝风复应,伏风随之复动,故迁延难治;若伏风久与痰瘀互结,形成宿根,则恶化为支气管哮喘,为时晚矣。

1.4 救肺能解一时之急,疗肝可为治本之道

综上所述,中医学视角下,CVA 是典型的直接病位在肺,间接病位在肝之病患^[14],具备“风袭于外,肝必内应”的病理逻辑,并可概括出“风袭于外,肝风内动,日久风伏”的病程特点。拾《内经》“诸风掉眩,皆属于肝”之言,知其病性属风,当知其位在肝;从肺论治可解一时之急,从肝论治方是治本之道。

2 从肝论治咳嗽的理论基础

2.1 体阴而用阳,肝为五脏万病之贼

肝属厥阴风木,又为将军之官,体阴而用阳;其用阳,性本喜动,疏阳易亢;其体阴,功在藏血,泄血易亏。自古徂今的医家们已认识到了肝功能关系系统对人体生理、病理变化过程的巨大影响。如魏之琇《续名医类案》^[15]云:“肝为万病之贼。”刘鸿恩《医门八法》^[16]曰:“诸病多生于肝,肝为五脏之贼。”黄元御《四圣心源》^[17]则言:“风木者,五脏之贼,百病之长。凡病之起,无不因于木气之郁。”

如今,现代系统科学把人的生命运动视作一个有机、复

杂的开放巨系统,肝功能关系系统作为其中的运动着的一个功能子系统,与其他脏腑的功能关系系统各司其职又彼此交互,共同维持人的生命运动^[18]。如清代魏念庭《金匱要略方论本义》“四时之气始于春,五脏之气始于肝”之言,肝功能关系系统“主疏泄,调气机,主藏血”的功能特点,决定了其与其他脏腑功能关系系统协作运动的生理、病理过程中处于相对主动的位置与序位。

综观古今各医家所论,大多肯定肝在各脏疾病的发病环节中都发挥着重要的使动作用。

2.2 生成之终始,肝肺分主气之升降

古时医家对肝肺的认识始于《素问·刺禁论篇》“肝生于左,肺藏于右”之论。其后讨论甚多,诸如《素灵微蕴》“阴阳之升降必由左右……右为肺金,左为肝木”之论,《本草述钩元》“木主升,金主降,升降相配”之论等等,大都认为肝之疏泄功能与肺之收敛功能对立统一,分主一身气机之升降。

而肝与肺对气机升降影响之有别,则在于两脏腑之本性。肝性喜动喜升,则肝之疏泄功能在于鼓动脏腑始生之气,主司气之疏通发泄;肺性喜润喜降,则肺之宣肃功能常在于收敛运行一周的脏腑之气,主司气之循节有律。正如《素问·天元纪大论篇》言:“金木者,生成之终始也。”肝木为始,主起而渐动之兴也;肺金为终,主周而复始之期也。

可见,历代医家对于肝肺生理关系的认识,主要在于“肝始而肺终”,肝升气而肺降气,肝兴气而肺律气,肝肺分主气之升降也。这就决定了病理层面上,肺之罹患盖源于肝之始乱。

2.3 肝刚而肺娇,肝木横恣可侮肺金

历代医家对待肝肺之病理关系,常从气机升降失常而论^[19]。如朱震亨“气血冲和,万病不生,一有拂郁,诸病生焉”之论,李冠仙之“肝气旺盛,不受金制,反来侮金,致肺之清肃不行”之论等,大都从此而论。张介宾在《类经》^[20]中言道:“肝为将军之官,其志怒,其气急,急则自伤,反为所苦。”《类证治裁·肝气肝火肝风》亦有言:“肝性升散,不受遏郁,郁则经气逆。”其皆阐述了肝郁自伤而导致肝肺气机升降失司、气行上逆发为喘嗽的病理路径与发病机制。

如《素问·五运行大论篇》言“气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不足,则己所不胜,侮而乘之”,一方面,肝既为五脏气之始源,其性升发刚强,则其气固强于为“娇脏”之肺,即“肝强肺娇”,故肝易侮肺而乘之;另一方面,肝本内寄相火,常处于“阳有余”之状态,肝木过郁必将化火,相火妄动克制肺金,则肺易受其刑,正如《医学衷中参西录》^[21]所言“肝中所寄之相火,因肝木横恣,更挟虚热而刑肺”。

3 “祛外风—煦肝风—搜伏风”的诊疗思路与方法

CVA 是一个由咳嗽逐渐发展为哮喘的动态阶段。学界关于 CVA 论治的方法很多,朱毅等^[22]对经方治疗 CVA 的文献资料进行了梳理,发现多数医家治疗中以解表化饮为主,宣肺化痰的方剂应用较广,从肝论治的思路较少;钱星佳等^[23]总结发现,以“疏风之法”内外合治 CVA,临床确有疗

效,一定程度上认识到肝肺同调的重要性;王友鹏等^[24]从风、湿论治小儿 CVA,明确了风邪内外相引是本病核心病机,但究其病位在肺脾肾,或因小儿肝气常有余,未能从肝论治;崔文成等^[25]则以“平寒”“清热”“解痉”“柔肝”四法,从肝论治儿童 CVA,疗效确切,对于成人 CVA 的论治有一定参考价值。

笔者团队结合多年临床经验,在此基础上认为:在其急性期的发病过程中,外感风邪是最直接且最有风险的诱发因素,是发病的导火索;但论及发病的根本原因,必须认识到与外风相应的是在肝的肝气、肝风,以及肝风难受制约的根源所在——肝阴血之不足。因此,要控制乃至逆转这个疾病进展、恶化的过程,仅从宣肺祛风的角度出发远远不够,需要兼顾肝肺相召之风,总结为“祛外风—煦肝风—搜伏风”的诊疗思路与方法。

3.1 祛外风——祛风为主,佐以缓肝

CVA 初起之时,患者往往出现受风而咳嗽不止的情况,此时病机首在风邪犯肺,次在引风于肝,扰动内风。患者肺受风邪,闭而失宣,多在于实,而虚尚轻,是故治以祛外风为要;既见肺闭失宣,当知风进则有动而扰肝之嫌,故应先安未受邪之地,佐以缓肝,使内风和缓,不应于外之骚动;凡风气郁闭,多郁而化热,熬津液而损之,故治应兼防阴虚。

3.2 煦肝风——平抑相火,调肝调血

病起些许时日,进入 CVA 的中期阶段,见呛无平期,夜间尤甚,则知肝风已动。此时似与初起症状相仿,只是加重;其病机却已非独肺气上逆,而是刺激性的、难以平息的气道痉挛。呛咳之反复,固因肺闭之肃肃难行,更是肝风之旋扰不息;既见肝风上袭于肺,当知木始挟火,肝中相火始挟虚热以上刑,肝内阴血必虚。此时治疗既当平抑相火,息风止咳,又须调养肝之阴血,用药上须注意虚象既显,便不可过用清化药以致虚甚。

3.3 搜伏风——搜剔逐邪,活血通络

到了 CVA 的后期阶段,见患者久咳缠绵,甚则已有喘憋之症,便知风已入络,结于痰瘀,疾病欲向典型哮喘发展。风既入络,则肝风外风皆化其标,本在风邪之伏也。叶天士对此给出的解决方案是,“久则邪正混处其间,草木不能见效,当以虫蚁疏通逐邪”,因此治疗当需在中期治疗的基础上,应用地龙、蛇蛻等虫药搜剔络中留恋之风邪。但归根结底,其内伤病情尚未如经典哮喘一般严重,不必苦寻宿根,诊疗重点仍在于络中之伏风。

4 “祛外风—煦肝风—搜伏风”思路下的方药应用

基于对 CVA 病机的独特认识,笔者团队在临床上以“祛外风—煦肝风—搜伏风”为整体思路,分期、分层次地用药。

对于 CVA 初起,其咳轻而气道挛急弱的患者,病位以肺为主,在气道之浅处,兼有肝风欲动之患,可用止嗽散为主方,佐以乌梅、防风调肝,是为“祛外风”之首则,“煦肝风”以辅之;对于 CVA 中期,刺激性咳嗽而呛无平期的患者,须知肺之失肃为标,肝风动摇为本,病位在气道之深者,方用麻杏

石甘汤合用加味过敏煎(防风 10 g、银柴胡 10 g、乌梅 10 g、五味子 10 g、生甘草 10 g、地龙 10 g),此以“煦肝风”法治本,“祛外风”法治标,更略用地龙以防风邪留恋之伏也,此为“搜伏风”之防变;至于 CVA 后期,即将恶化为支气管哮喘之时,可在前方基础上多合用蝉蛻、蛇蛻、水蛭等平肝通络之虫药,以强“搜伏风”之功。临床用药时,可根据患者突出症状、本身体质与当时的运气环境,稍作化裁:如兼有痰浊者,加二陈汤;兼有大便干者加大黄、芒硝;兼阴血虚者加麦冬、天冬、阿胶珠;咳久者加诃子肉等。

5 验案举隅

患者,男,28 岁,2023 年 2 月 15 日就诊。自诉其咳嗽 4 年,每逢春季则复发加重,咽喉及气道痒感频作,今春已咳月余,遇风而甚。刻下其脉弦细微数,舌红苔少而黄,舌下络脉青紫。诊断:咳嗽变异性哮喘。处方:麻杏石甘汤合加味过敏煎加减,具体处方如下:蜜麻黄 10 g、炒苦杏仁 10 g、生石膏^{先煎} 15 g、甘草 10 g、银柴胡 15 g、乌梅 15 g、醋五味子 15 g、防风 15 g、地龙 15 g、桔梗 10 g、蜜紫菀 10 g、蜜百部 10 g、生枇杷叶 10 g、桑叶 10 g、蜜桑白皮 15 g、制水蛭 3 g、麸炒枳壳 10 g、蝉蛻 15 g、前胡 10 g、天冬 10 g、荆芥 10 g。上药每日 1 剂,水煎服。服药 7 剂后,诉咳喘皆止,嘱其去麻杏石甘汤与蜜炙止咳药,再服 7 剂。随访,喜诉未复。

按 该患者就诊时已咳嗽 4 年,且好于春季发病,根据就诊证候,辨病、辨证为 CVA 之肝气犯肺证,病性虚实夹杂,外受风寒而内热。患者平素胸闷易怒,可见本有肝郁;又逢春季肝主时令,其气盛而过用,外实内虚。虚,则阴血过泄耗于其内,肝风遂动;实,则外风内火击于气道,发为咳喘。案中,咽喉气道痉挛痒感,是为外风引动肝风上扰、肺热阴伤之故;脉弦细微数,其弦一为春之当令,二为肝之壅郁,其弦细而数,方知阴液有虚;舌红苔少而黄,为肝之火炽,煎熬阴血,继而阴血不足,虚火杂生;舌下脉络青紫为肝络之瘀阻。遍观患者之证候,则可见由外风引肝风而起、虚火与实热夹杂,上灼则伤肺阴,气道痉而咳喘发。根据患者临床证候,全方先“祛外风”,立解其咳喘难解之窘急;急标既解,则“煦肝风”,不予更泻,重在补肝肺阴,平其风动,借时运以复其肝之敷和;并“搜伏风”,添虫药剔除内恋之邪,防其伏风复动,标本兼治,疗效确切。

6 结语

CVA 具有向经典哮喘发展的倾向性,多被视作经典哮喘的前发征兆。笔者团队总结认为 CVA 病因以“风”为主,病程与病机展现出“由外及内,日久则伏”的特点。故本文基于“风袭于外,肝必内应”的辨证思路,总结提出“祛外风—煦肝风—搜伏风”分层次从肝论治 CVA 的诊疗方法,此法临床实践疗效显著,值得同道借鉴,以期对 CVA 的临床治疗提供新帮助。

参考文献

- [1] Miss International morning. Cough variant asthma(Review)[J].

- Journal of Clinical Pediatrics, 1996, 14 (3): 204-205.
- [2] ZHOU G H, ZENG Q C, WEI W, et al. A pilot study of differential gene expressions in patients with cough variant asthma and classic bronchial asthma[J]. Journal of Asthma, 2021, (4): 1-16.
- [3] 于晓敏, 李国华, 杨广源. 从风论治咳嗽变异性哮喘的研究进展[J]. 内蒙古中医药, 2021, 40(3): 150-152.
- [4] 晁恩祥. “风咳”证治探要[J]. 江苏中医药, 2008, 53(7): 8-9.
- [5] GAO J, WU H G, WU F. Small airway dysfunction in patients with cough variant asthma: A retrospective cohort study[J]. BMC Pulmonary Medicine, 2021, 21(1): 49.
- [6] 苗青, 刘永革, 王燕, 等. 不同致敏模式支气管哮喘患儿外周血 T 淋巴细胞亚群比较及临床意义[J]. 中国免疫学杂志, 2018, 34(1): 84-90.
- [7] 刘圣康, 崔红生, 王成鑫, 等. 从风与湿论治咳嗽变异性哮喘[J]. 环球中医药, 2020, 13(4): 663-665.
- [8] 杜渊, 王蔚, 马君蓉. 从风痰瘀论治小儿咳嗽变异性哮喘[J]. 四川中医, 2014, 32(2): 47-48.
- [9] 李彦军, 马淑然, 肖延龄, 等. 论风邪在过敏性哮喘发病机制中的重要作用[J]. 上海中医药杂志, 2010, 44(10): 47-49.
- [10] 冯淬灵, 武维屏. 武维屏教授治疗咳嗽变异性哮喘经验[J]. 北京中医药大学学报, 2009, 32(8): 574-576.
- [11] 侯岁明. 浅谈行痹治肝与和解少阳[J]. 河北中医, 2001, 23(3): 233-234.
- [12] 马培之, 李文荣, 邵同珍. 马氏医论·知医必辨·医易一理·和缓遗风合集[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2013: 114-115.
- [13] 清·叶天士. 临证指南医案[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 3.
- [14] 刘宇, 白丽, 王盛隆, 等. 基于“从肝治肺”论治慢性阻塞性肺疾病[J]. 中医药临床杂志, 2022, 34(10): 1798-1802.
- [15] 清·魏之琇. 续名医类案[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1957: 908.
- [16] 清·刘鸿恩. 医门八法[M]. 北京: 中医古籍出版社, 1986: 4.
- [17] 清·黄元御. 四圣心源[M]. 李玉宪, 主校. 北京: 人民军医出版社, 2010: 21-22.
- [18] 祝世讷. 中医系统论基本原理阐释[J]. 山东中医药大学学报, 2021, 45(1): 7-21.
- [19] 李映霞, 王开盛, 徐超. 从肝论治肺系疾病思路浅析[J]. 江西中医药, 2022, 53(12): 12-14.
- [20] 明·张介宾. 类经[M]. 北京: 中国中医药出版社, 1997: 25.
- [21] 清·张锡纯. 医学衷中参西录[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 1985: 285.
- [22] 朱毅, 赵稼莹. 咳嗽变异性哮喘经方治疗研究进展[J]. 贵州中医药大学学报, 2023, 45(2): 86-90, 94.
- [23] 钱星佳, 吕红. 从“风”论治咳嗽变异性哮喘的研究概况[J]. 中医临床研究, 2022, 14(21): 48-51.
- [24] 司秀影, 梁娜, 刘洋, 等. 从“风”“湿”论治小儿咳嗽变异性哮喘概述[J]. 辽宁中医杂志, 2022, 49(7): 58-61.
- [25] 郭米兰, 张慧敏. 崔文成从肝论治儿童咳嗽变异性哮喘之经验[J]. 江苏中医药, 2022, 54(6): 29-31.

(收稿日期: 2023-04-20)

(本文编辑: 韩虹娟)